

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Biologia Celular, Embriologia E Genética
PPG Biologia Celular e do Desenvolvimento
Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE)

Pós-doutorando: Dr. Tiago Fernando Chaves

Supervisores: Profa Dra Yara Costa Netto Muniz & Daniel Pacheco Bruschi



Case 2:

 Prontuário Clínico: Ben Solo

Identificação do Paciente

- **Nome:** Ben Solo
- **Data de Nascimento:** 01/10/2025
- **Idade:** 0 dias (Recém-nascido)
- **Sexo:** Masculino
- **Cor:** Caucasiano
- **Registro:** FALCON-2025-0001
- **Data da Anamnese:** 01/10/2025

História Clínica (HDA) - Recém-Nascido

Recém-nascido (RN) de parto cesariano, realizado após ultrassonografia pré-natal de rotina que detectou múltiplas anomalias estruturais. O bebê foi admitido na UTI Neonatal em **condição grave** e com **insuficiência respiratória** (APGAR 3/5/6).

Achados ao Nascimento:

1. **Anomalia Craniana:** Presença de uma grande massa cística preenchida por líquido projetando-se da região posterior do crânio, na área occipital.
2. **Anomalia Renal:** Abdômen distendido e palpável. Oligúria observada imediatamente pós-parto.
3. **Anomalia de Extremidades:** Presença de dígitos extra (supranumerários) em ambas as mãos.

Devido à gravidade das malformações cerebrais e renais, o prognóstico é reservado/sombrio.

História Familiar (HF)

- **Pai (Han Solo):** 45 anos, saudável. Sem histórico relevante de malformações congênitas na família.
 - **Mãe (Leia Organa):** 45 anos, saudável. Nega consanguinidade na família imediata.
 - **Histórico Secundário:** A mãe relata um **aborto espontâneo** no primeiro trimestre há 10 anos, cuja causa nunca foi determinada. O restante da família nuclear e extensa é aparentemente saudável.
-

Exame Físico

- **Estado Geral:** Grave, letárgico, cianótico. Necessitando de ventilação mecânica.
 - **Dismorfias Cranianas:** Presença de **Encefalocele Occipital de grande volume** (massa cística na nuca, medindo aproximadamente $8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$). Fontanelas amplas.
 - **Abdomen:** Distendido, indicando massa abdominal subjacente.
 - **Genitália:** Hipospádia (abertura da uretra na parte inferior do pênis).
 - **Membros: Polidactilia Pós-Axial Bilateral** nas mãos (6º dedo rudimentar presente em ambas as mãos).
 - **Face:** Discretas anomalias faciais, incluindo narinas antevertidas e micrognatia.
-

Exames Complementares (Achados Chave)

- **Ultrassonografia Renal (Imediatamente Pós-parto):**
 - Rins bilateralmente **aumentados de volume (renomegalia)**, com **perda da diferenciação córtico-medular** e substituição do parênquima por **múltiplos cistos de tamanhos variados** (Displasia Renal Cística Multissistêmica).
 - **Tomografia Computadorizada Craniana:**
 - Confirmação da **Encefalocele Occipital** (protrusão de tecido cerebral e meninges).
 - **Displasia do Tronco Encefálico** (Ponte e Cerebelo).
 - Hipoplasia do telencéfalo.
 - **Laboratório:**
 - Elevação significativa de ureia e creatinina (Azotemia), compatível com **insuficiência renal aguda/crônica**.
-

Impressão Clínica (Malformações Múltiplas Congênitas)

Recém-nascido apresentando uma **tríade de malformações congênitas maiores**:

1. **Displasia Renal Cística Bilateral Severa** com insuficiência renal (Achados abdominais e laboratoriais).
2. **Encefalocele Occipital** (Anomalia do tubo neural).
3. **Polidactilia Pós-Axial Bilateral** (Anomalia de extremidades).

Nota: A combinação destes três defeitos congênitos maiores, juntamente com hipoplasia de outras estruturas cerebrais, aponta para um defeito genético único, grave e pleiotrópico, com alto risco de letalidade perinatal.

Plano de Conduta

1. **Cuidados Paliativos:** Devido à gravidade das malformações cerebrais e renais (incompatíveis com a vida a longo prazo), a equipe deve focar em conforto e suporte paliativo, com discussão imediata com os pais.
 2. **Investigação Etiológica:** Coleta de amostras para **análise citogenética e sequenciamento genético (Painel de Ciliopatias/Síndromes de Malformações Múltiplas)** para confirmar a etiologia.
 3. **Aconselhamento Genético:** Agendamento prioritário para os pais para discussão sobre a recorrência, natureza da condição (provavelmente autossômica recessiva) e planejamento de futuras gestações.
-